

l'embryon primitif, avec un pôle embryonnaire qui est un pôle assimilateur, et il va toujours, toujours rentrer dans la muqueuse, toujours par ce pôle. Ici j'ai dessiné la muqueuse utérine, on voit ici l'embryon, vraiment avec ces cellules qui sont capteurs d'informations. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de cette cellule ici, il y a une couche de cellules, donc ceci ça s'appelle, comment on l'appelle cette cavité ? La flasque de selle. Cette couche ici ça s'appelle comment ? Le bouton embryonnaire. Et puis tout en avant ici, juste ici, on va appeler les cellules, ils vont prendre un nom un peu chinois, ça va s'appeler le syncytiotrophoblast. Syncytio ça veut dire qu'il y a une activité lipique, donc une activité assise. Soit la muqueuse n'est pas prête, on ne veut pas accueillir, on n'est pas prêt. Ou, et ça c'est très fréquent, l'embryon n'est pas assez fort, parce que très fréquemment, dans les premiers stades des fausses couches qui se font avant, il peut y avoir des anomalies, et très fréquemment à ce niveau-là, c'est les premières fausses couches, c'est que l'embryon n'est pas assez fort. Va arriver... Elle va donner, et donc c'est déjà cette force-là. Si cette force n'est pas puissante, si le métabolisme n'est pas assez puissant, si l'animation... L'âme, quelque part, n'a pas reçu cette puissance, on ne pourra pas entrer dans la muqueuse, et naturellement, ça va s'éliminer, ça va reprendre. Et c'est ça, un sitiotrophogaste, elles vont libérer ici, un acide, au point que ça va être une agression pour la muqueuse. C'est-à-dire que la muqueuse qu'elle a, elle va... C'est comme si tu verses de l'acide, là. Donc le système, il peut commencer à... Je vais aller me mettre dans mon nid bien chaud. On va voir, premièrement, un petit dessin animé. Et là, je voudrais que vous observiez ce qui se passe, qu'on va le voir en couple. Et un autre film où on va le voir, pas en couple, mais plus en réalité. Et c'est un moment important de votre vie, parce que c'est presque une incarnation. C'est presque le moment où on veut bien s'incarner. Parce qu'on rentre dans la chair. On rentre dans la

muqueuse de la mer. On rentre dans la... On s'incarne, on rentre vraiment dans la terre. Très tôt, on a ce qu'on appelle des jonctions cellulaires. Et ces jonctions cellulaires seront dépendantes d'une substance qu'on appelle le calcium. C'est pour ça que les cellules d'adhérents, Ça s'appelle des cadérines, qui sont des ions calciques, qui donnent la force de cohésion. Au moment où on arrive dans la muqueuse de l'utérus, l'embryon a fait tout son parcours. On voit qu'il y a une zone de cellules concentrées. Et en avant de cette cellule de zone concentrée, on a une petite couche de cellules qui vont changer de nom. Ceux-là, ils vont s'appeler le syncytiotrophoblast. Ça veut dire qu'on est... C'est une activité lithique. Elles vont rentrer, libérer en fait carrément un assis et rentrer dans la muqueuse. C'est vraiment une agression au point que ça fait des micro-saignements. au même point que ça fait comme une micro-sicatrice au niveau de l'utérus, la zone d'implantation, et au même point que ça peut donner une confusion sur les dates des dernières règles. Parfois la femme, elle fait, oh, tiens, j'ai eu au sixième jour, elle dit, tiens, j'ai eu des saignements, peut-être que, et ça peut amener à une confusion. Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'on rentre toujours par le pôle assimilateur et de façon bien droite. Jamais de travers, il n'y a pas de déviation, sinon ça risque de ne pas rentrer. Ça rentre, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un champ métabolique, il y a une absorption très très puissante qui vient rechercher l'envie de vivre. C'est vraiment, en fait, une recherche de vie. J'accepte la vie, je veux vivre. Je lance mon acide et je tente ma chance de rentrer. Si j'ai assez de puissance pour y arriver, tu vois. Donc c'est à la fois, c'est vraiment un choix presque de l'âme, si tu veux, de s'incarner. Donc d'abord, il rentre bien par le pôle qu'on appelle les micromères. Et là, on va maintenant regarder vraiment cette image-ci. Tu vois, on voit ce qu'on appelle le blastocèle ici. Je vois les cellules, tu vois, qu'on appelle le bouton embryonnaire. Et on voit ici les cellules qui sont là,

qu'on appelle le syncytiotrophoblaste. Et le liquide qui coule, c'est le syncytiotrophoblaste. Qui vient vraiment ronger et rentrer dans la muqueuse. Dans la muqueuse ici, on voit qu'elle est riche. Elle est gonflée, elle est riche en vaisseaux, en artères, en petites glandes utérines, etc. Pour accueillir et permettre de nourrir le zygote qui arrive. Et regardez ce qui va se passer. Un, il rentre complètement dans la muqueuse. Ok ? Deuxièmement, au moment où il rentre, on voit qu'il y a toutes les cellules qui sont autour ici. Mais si on regarde maintenant que l'embryon, on voit que c'est ici. Et qu'est-ce que vous avez vu ? On voit apparaître une petite cavité dans l'embryon. Regardez, marche arrière. Tac, pas de cavité. Au moment où je rentre, hop, apparaît une cavité ici. Tu vois ? Vous voyez la petite cavité là ? Là, pareil, je rentre complètement. Et qu'est-ce qu'on voit aussi ? Regardez, là ici, on voit vraiment qu'il y a une différenciation entre les cellules qui sont ici. On voit vraiment... et des cellules qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont en regard de la cavité qui apparaît, et cette petite cavité, ça s'appelle la cavité amniotique primitif. Et ici, on voit des cellules qui se mettent autour de cette cavité. Donc les cellules qui sont en regard de la cavité amniotique sont les cellules épiblastiques. Les cellules qui sont en regard de la cavité du blastocèle sont les futures cellules hypoblastiques. En d'autres termes, ça veut dire que ce sont des cellules de type endodermique. Un qui regarde la cavité amniotique, qui est ici, deux, les autres regardent la cavité du blastocèle. Ces cellules ici participeront plus tard à la formation d'une autre cavité. Ça, je vais vous l'expliquer, ce sera un peu plus difficile à comprendre. On va aller un peu plus loin dans cette cavité amniotique. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous imaginez qu'à ce moment-là, j'ai déjà comme une différenciation cellulaire qui apparaît. C'est déjà des cellules qui sont en regard de cette cavité, et derrière, c'est des cellules qui sont en regard d'une autre cavité. Et donc, ce qu'on doit

réfléchir, c'est que j'ai deux cavités qui apparaissent, Tout ce qui sera hypoblastique donnera le système digestif futur, et tout ce qui sera épiblastique donnera le système neuronal futur. Et tout ce qui sera... Alors, regardons un peu le mécanisme un peu plus subtil. J'ai faim, quoi. Il me faut manger. Donc, j'arrive. Mais on est toujours dans ces processus. N'oubliez pas, qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là ? Vous vous souvenez de ce qu'on a vu ce matin ? Je m'informe moi-même, je m'informe mon copain, qui informe ici ma copine, qui t'informe là, et tout, tu vois ? Et en même temps, on avait vu qu'il y avait... Si je me sautais du building, il ne restait plus que du liquide, quoi, de moi, par terre. Eh bien, vous imaginez ici, maintenant, la cellule, elle rentre. Moi, je suis la cellule, je rentre ici. Mais là, j'ai une contrainte, mais non, je ne rentre pas comme dans du bain, Je rentre là, et c'est bon. Je lui dis, ben, un peu d'acide, je vais essayer de pousser, mais il faut que je rentre là-dedans. Donc, les cellules qui sont là, au départ, elles reçoivent une information trophique, Les cellules qui sont derrière, ici, elles sont encore nourries par la cavité amniotique du blastocèle, Mais les cellules qui sont au centre, elles commencent à être comprimées, déficientes en nourriture, elles étaient déjà là, au bout, tu vois, au niveau de la membrane, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On voit apparaître ici, tout d'un coup, eh bien, les cellules, la membrane qui disparaît. Tu vois ? Et qu'est-ce qui reste ? C'est un exudat. Ce qui va rester, c'est un petit exudat cellulaire qui apparaît ici. Et cet exudat cellulaire, c'est l'ébauche, simplement, de la cavité amniotique. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours déjà un processus de croissance. Qu'est-ce qu'il va devenir cette cavité amniotique ? Premièrement, de façon externe, elle deviendra, à la fin, ce qu'on appelle la poche des os. C'est une cavité amniotique primitive. Regardez comment ça va évoluer. Ça va complètement emballer l'embryon, complètement entourer. Et puis, tout ça, c'est de la cavité amniotique. Petit exudat liquidien. Et à la fin, je nage dans

cette cavité. Et je suis baigné. Et on va voir qu'après, ça va grandir d'une façon différente. Parce qu'il y a des cellules qui vont changer de nom, qui vont devenir des amniotes, qui vont commencer à nourrir, à faire grandir. Mais autre chose, qu'est-ce que j'ai comme tissu qu'il y a ici ? Cellules épiblastiques. Et là, hypoblastique. Et les cellules épiblastiques, ça va devenir quoi ? Le système nerveux. C'était un nerveux ! Et ton système nerveux, à la part, c'est une couche de cellules. qu'on appelle la plaque neurone, Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai de la plaque neurale, un peu plus tard ? C'est quoi comme liquide ? Du liquide amniotique qui va être pris dans la fermeture de ma gouttière neurale, qu'on verra demain en détail, enfin, au après-demain, je ne sais plus, comme ça, qui va complètement enfermer un liquide à l'intérieur de votre cerveau. Et comment ça va s'appeler ce liquide ? Le liquide, c'est phalorégénien. primitif qui vient en fait de la cavité amniotique donc non seulement à l'intérieur de la profondeur de ton être parce que franchement cette cavité c'est profond on oublie qu'on a cette cavité liquidienne en nous, que tu as ton système ventriculaire et que tu as ce liquide complètement au centre de toi comme un petit phylome, complètement au centre de toi, c'est déjà du liquide amniotique. Et complètement à l'extérieur de toi, c'est quoi ? C'est du liquide amniotique. Et en plus, quand tu as un embryon à ce stade-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu piques du liquide amniotique. Tu bois du liquide. Tu t'informes complètement. Pourquoi ? Parce que c'est un liquide plantellant. C'est un liquide complètement autocrine, paracrine. Tu t'informes complètement. Tu t'informes de pression interne, de pression ici, et comme par hasard, on va voir plus tard, que l'intégration de ton cellulome, donc la fermeture de ta cavité péritonéale, va se faire au même moment que la fermeture de ton tube neural. C'est des synchronicités, des inductions spécifiques. Ça va se faire au même moment. Ici, c'est encore un zygote. Mais le fœtus apparaît quant à le processus axial

primitif, c'est-à-dire la mise en place de la gastrulation. Là, il y a une forme fœtale. Ça, c'est un petit zygote qu'elle a. Le reste, on est dans le paysage lunaire de la femme, mais avec une terre bien riche en muqueuses, bien riche en glandes, en nourriture. Et c'est là qu'on va faire ce moment, ce choix, où je peux rentrer dans ma muqueuse. On voit qu'il cherche à s'adhérer à rentrer, là. Il commence à envoyer des... Comment on dit ça ? Des... De l'acide ! C'est un peu... Tu vois ? Il y a une activité métabolique très importante. Et maintenant, il faut regarder ici, tout le monde, mesdames, messieurs, là-bas, regardez. Regardez bien. Je rentre dans la muqueuse. Huitième jour, cavité amniotique. On voit apparaître ici une pression à droite, une pression à gauche. Et c'est ça qui crée une force de pression qui est ici, tu vois. C'est là que va apparaître cette cavité amniotique. Et c'est là, quand j'ai dans ce bouton embryonnaire, au moment où j'ai cette cavité, j'ai des cellules qui s'organisent et qui s'orientent vers ma cavité amniotique et des cellules qui s'organisent et qui s'orientent vers ma cavité amniotique. Et c'est là que j'ai l'apparition d'un épiblaste et d'un hypoblaste. C'est déjà là que j'ai un stade où je peux dire que j'ai une phase de type digestif et une phase de type, un tissu digestif qui se prépare et un tissu de type neurologique.